

07. DAS HERZ : EINFÜHRUNG UND URSPRÜNGE

DAUER : 11:43

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video bietet eine ausführliche Einführung in die zentrale Rolle des Herzens in der Embryonalentwicklung. Das Herz, das bereits am 21. Tag des intrauterinen Lebens zu schlagen beginnt, spielt eine entscheidende Rolle bei der Informationsverteilung und beeinflusst das Neuralrohr und das Verdauungssystem über autokrine und parakrine Mechanismen. Die Interdependenz zwischen dem Herzen des Kindes und der Gesundheit der Mutter wird ebenfalls thematisiert, wobei betont wird, dass Kinder bis zum Alter von 7 Jahren, einem wichtigen Zeitpunkt ihrer Entwicklung, energetisch mit ihrer Mutter verbunden sind. Es werden auch die primitiven Ursprünge des Herzens, seine asymmetrische Position und die bereits bei der Befruchtung etablierten Polaritäten untersucht, wodurch die komplexe Wechselwirkung zwischen Biologie und Embryologie und deren Einfluss auf die zukünftige Gesundheit des Individuums veranschaulicht wird.

DAS HERZ: EINFÜHRUNG UND URSPRÜNGE

DAS HERZ, MOTOR DER ENTWICKLUNG

Ihr **Herz** beginnt am **21. Tag** des intraembryonalen Lebens zu schlagen. Nach drei Wochen ist es das erste System, das funktioniert, und es wird diese Funktion sein ganzes Leben lang aufrechterhalten: die **Verteilung von Informationen**.

Sobald das Herz schlägt, beschleunigt sich der **Wachstumsprozess**. Der erste, der diese wichtige Information vom Herzen erhält, ist das **Neuralrohr**, das gesamte Gehirn.

Das Herz ist der Motor, der ansaugt. Es gibt eine sehr wichtige und funktionelle Beziehung zwischen Herz und Gehirn. Das Herz gibt dem Gehirn die Kraft.

Studien haben gezeigt, dass im **tiefen ventrikulären System** eine direkte pulsierende Vibration des Herzens existiert, die das Gehirn informiert. Es gibt eine direkte Verbindung auf sehr subtilen Ebenen.

DAS HERZ UND DIE INFORMATIONSVERTeilUNG

Das Herz verteilt Informationen. Aber welche Informationen? Es verteilt die **"Nahrung"**, in enger Beziehung zum **Verdauungssystem** und der Verbindung zur Mutter.

Sie bringen eine trophische Information, die von Ihrem Herzen organisiert und von Ihrem System umverteilt wird. Sie sind also in Ihrer Entwicklung von Ihrem **Entoderm**, Ihrem Verdauungssystem, abhängig.

Autokrin, parakrin, verdauungsfördernd, und erst danach erscheint das System sichtbar.

DAS KINDERHERZ UND DIE MÜTTERLICHE BINDUNG

Wenn wir an dieser Bindung zu einem Kind arbeiten, ist es oft notwendig, die **Mutter** zu behandeln. Wenn die Mutter in ihrer Funktion nicht frei ist, kann sich das Kind auch nicht befreien, da es energetisch abhängig sein wird, mindestens bis zum **7. Lebensjahr**.

Auf zellulär-energetischer Ebene werden alle Zellen Ihres Körpers nach 7 Jahren erneuert. Dies wird als **"der neue Körper"** bezeichnet. Es ist seine erste Geburt, der Moment, in dem es **"die Vernunft"** erlangen kann.

Dies ist der Moment, in dem sich sein **Stirnhöhle** öffnet und seine **Schilddrüse** vollständig elektrisch wird, weil sie sein Herz neu informiert hat. Deshalb kann man das Herz aus der Ferne spüren.

Es wird von der **Neuralleiste** informiert und hat seine Information weitergegeben. Mit 7 Jahren kann sich das Kind in seiner Umgebung verteidigen, es findet seine erste Unabhängigkeit.

URSPRÜNGLICHER URSPRUNG DES HERZENS

Die Herzanlage erscheint im **splanchnopleuralen Mesoblast**, auf einer primitiven Ebene. Wiederum wird es vom gesamten **Dottersystem** abhängig sein.

Hier finden wir eine präsumptive Kraft des Herzens vor der **Gastrulation** und vor dem Gefäßplan, entlang der **kardiogenen** Zellen des Epiblasts. Es hat bereits sein gesamtes Potenzialfeld.

Wenn ich ein **Kreuzbein** oder ein **Steißbein** nehme und mich in das System begeben, habe ich bereits die Geschichte des Herzens, die sich präsentiert. Ich muss also beginnen, das Herz zu behandeln, indem ich die **Primitivrinne** unter dieser ersten sich entwickelnden Welle befreie.

SYMMETRIEBRUCH UND HERZPOSITION

Der Bruch der **Symmetrie** erfolgt bereits bei der Etablierung des **Notochordalprozesses**. Es gibt einen nodalen Fluss mit kleinen Zilien, die zerebrale Vesikel von rechts nach links transportieren, über die Sonetik **HH**, das **FGF8**, und schließlich eine Änderung der **Retinsäure**.

Dies induziert eine Veränderung auf der **Kalziumebene**, die eine unterschiedliche Integration in die genetische Information bewirkt. Letztendlich kommt es zu einem Bruch der Symmetrie von rechts nach links, wobei auf dieser Ebene eine wichtige Information gegeben wird.

Dieser Symmetriebruch wird einer der Faktoren sein, der das Herz zukünftig nach links positioniert. Dies geschieht durch **morphogenetische Moleküle**, mit einer Erhöhung des Kalziumspiegels auf einer gesamten lateralen Platte, und somit wird die gesamte Information der genetischen Integration unterschiedlich sein.

Diese Asymmetrie erfolgt zwischen der Schädelbasis und dem Kreuzbein, mit der Primitivrinne. Die Abweichung ist vorhanden: Es ist ein Fluss, der von rechts nach links kommt.

POLARITÄT UND EINFLUSS DES SPERMIIUMS

Dies findet sich auf einer anderen Ebene durch die **follikulären Nährzellen**, die Enzyme freisetzen. Sie erzeugen bereits eine **Polarität** innerhalb der Eizelle, im Zytoskelett.

Eine erste Polarisierung erfolgt auf einer **kranio-kaudalen** und **dorsoventralen** Ebene, auch wenn die Eizelle noch nicht über ihre äußere Umgebung informiert ist.

Es wird festgestellt, dass der Ort des Eindringens des **Spermiums** eine Neuinformation in der Längsachse des Embryos geben wird, wo diese präsumptive Kraft erzeugt wird.

Diese Integration ist bereits eine Information von außen durch die Kraft des Spermiums, das die Kraft des Zytoskeletts auf einer fast **elektromagnetischen** Ebene restrukturiert. Einige beschreiben, dass dies im apikalen Teil des Embryos zu finden ist.

Das bedeutet, dass man ein präsumptives Informationsfeld erfasst. Und in diesem präsumptiven Feld wird man die zukünftige **kardiogenetische** Phase finden.

Das Spermium repräsentiert bereits in gewisser Weise die Herzkraft, die sich dort vorbereitende Pulsation. Aber es gibt hier noch keine Form, es ist eine Vorform.

ORGANISATION DES EMBRYOS UND HERZBILDUNG

Wir werden sehr schnell sehen, dass sich eine ganze Organisation des Embryos mit der berühmten **"Welle"** entwickeln wird, mit einem Stützpunkt hier und einem Stützpunkt dort, mit der Primitivrinne und mit der Reintegration dieses Systems.

Die Bedeutung dieser Punkte ist entscheidend. Der zweite Punkt wird der Moment sein, in dem ich die Welle habe, das heißt den Übergang zur Etablierung meiner **dritten embryonalen Kammer**, des **Zöloms** oder des **externen Dottersacks**.

Dies wird den Embryo reorganisieren und eine **S-förmige** Struktur schaffen. In diesem Moment werde ich die Integration in Bezug auf den Anheftungspunkt haben, und das ist es, was meine Primitivrinne bildet. In einem Embryo ist das Herz dort.

DAS HERZ, DAS PERIKARD UND DAS ZWERCHFELL

Das Herz hat seinen Platz gefunden, es hat das **Perikard** und das **Septum transversum** integriert, mit diesen **Zwerchfellpfeilern**, die einen Stützpunkt für das Herzsystem bilden werden.

Ein Herz zu behandeln bedeutet, das Zwerchfell zu befreien, da seine Ausrichtung dies bewirkt. Das Zwerchfell wird wirklich unser therapeutisches Werkzeug, da die Perikardzellen dieselben Zellen sind, die sich auf der Ebene des Septum transversum, also des Zwerchfells, wiederfinden.

Woher stammen sie? Ich habe mein Herz, und dort habe ich kleine **Mesenchymzellen**, die mein Zwerchfell bilden werden. Das Ektoderm wächst vollständig, und das schwingt und wird dieses ganze System bilden.

DIE AUSWIRKUNGEN VON ANERKENNUNG UND FRUCHTBARKEIT

Das Spermium kommt an, und der **"Schlüssel"** für die Begegnung ist da. Die Pille hat das Konzept, die Möglichkeit der Empfängnis, getötet. Das Hormonsystem wurde jahrelang unterbrochen.

Immer mehr Frauen haben Schwierigkeiten, schwanger zu werden. Eine medizinische Ebene hat eingegriffen und gesagt: "Jetzt können wir Ihnen helfen." Man macht sogenannte **"IMSI"**, bei denen man eine Nadel nimmt, sticht und die Membran durchdringt.

Man hofft, in Bezug auf die Polarität am richtigen Ort zu sein. Nur hat man nicht die erste Anerkennung, die eine membranöse, koronare, gewebliche, molekulare Anerkennung ist.

Wahrscheinlich werden diese Kinder zunehmend Fruchtbarkeitsprobleme haben. Sie werden sich also nicht mehr fortpflanzen oder erkennen können. Die erste Anerkennung wurde entfernt.

Diese Kinder, die zur Konsultation kommen, müssen anerkannt werden. Auf welcher Ebene des Körpers sollen sie anerkannt werden? Ihr Herz. Man muss sie durch den Blick in ihr Herz kontaktieren.

Wenn Sie das tun, weiß das Kind es. Das ist das Einzige, was Sie geben können. "Ich kann dich erkennen, dich wiedergeboren machen." Sonst werden diese Menschen ihr ganzes Leben lang auf der Suche sein.

METABOLISCHE KRAFT UND ANFÄNGLICHE ENTWICKLUNG

Dies geschieht bereits in Ihrem **primitiven Gefäßsystem**, am fünften oder sechsten Tag. Die **Zygote** muss eine metabolische Kraft in einem spezifischen Pol haben.

Der **zelluläre Trophoblast** muss sich in einen **Synzytiotrophoblasten** umwandeln. Dieser Synzytiotrophoblast hat eine lytische Aktivität, um in die Schleimhaut eindringen zu können. Wenn der Embryo diese Kraft nicht hat, kann er nicht in die Schleimhaut eindringen.

Zweitens muss die Mutter aufnahmebereit sein. Aber sie ist es nicht, die die Arbeit für den Embryo leistet. Hat er diese Kraft erhalten?

Seine metabolische Kraft wird zunächst durch eine Phase der **zellulären Dedifferenzierung** bestimmt. Während der ersten drei, vier Tage wächst die Zygote nicht.

Im Gegensatz dazu erhöht sie ihre **Zellteilung**, bei der Furchung, mit hoher Geschwindigkeit. Es gibt eine globale Zunahme der Membran und einen kleinen Wasserverlust nach außen.

Dort wird sie diese erste Höhle schaffen, die man "**Keim des Himmels**", die **Blastozyste**, nennt, die eine spezifische Verbindung zu Ihrem "**äußeren Himmel**" ist.

Anschließend wird es auf zellulärer Ebene eine Zunahme der Membran geben. Wenn die Membran zunimmt, nehmen die Austauschvorgänge zu. Membranen sind Austauschräume, immer polarisiert.

Wenn ich eine Zelle habe, habe ich einen Kern, und ich sehe, dass mein Kern konzentriert ist. Hier habe ich meine größte Austauschkraft. Anstatt 50 zu haben, werde ich 3000 haben.

Die Zellen in dieser Teilungsphase werden **200-mal kleiner** als die beiden ursprünglichen Blastomere. Relativ gesehen nimmt meine Membran zu.

Wenn ich meine Membran im Vergleich zu meinen ersten beiden Blastomeren nehme, sagen wir, das sind 100 Meter. Wenn ich all diese kleinen Membranen nehme, nehme ich enorm zu.

Ich erhöhe meine metabolische Kraft. Wenn ich eine ausreichende metabolische Kraft habe, habe ich genügend Kraft, um einzudringen.

DIE METABOLISCHE KRAFT FÜR DAS LEBEN

Diese metabolische Kraft werde ich immer brauchen, mein ganzes Leben lang. Es ist ein bisschen die "**Batterie**", die Sie erhalten werden. Und Sie müssen darauf vertrauen.

Sie regeneriert sich bis zu einer gewissen Zeit durch Ihren **Schlaf**, Ihre **Ernährung**, Ihre **Atmung**, Ihre richtigen Gedanken usw. Sie degeneriert, wenn Sie dies nicht respektieren und wenn Sie vergiftet sind.

Sie verlieren Ihre grundlegenden Substrate dieser Kraft. Sie brauchen das also. Das Herz hat seinen Ursprung praktisch im Kontakt des Spermiums, in dieser Begegnung, symbolisch.

Danach findet man es auf der Ebene der Primitivrinne. Dann eine Information bereits der Herzfelder, die sich hier im Zusammenhang mit dem Vorhandensein eines gesunden Ödems bilden, das ist in der Wachstumswelle der Entwicklung der Herzfelder.

Und dann werden wir etwas sehr Wichtiges sehen, das ist die gesamte Entwicklung.

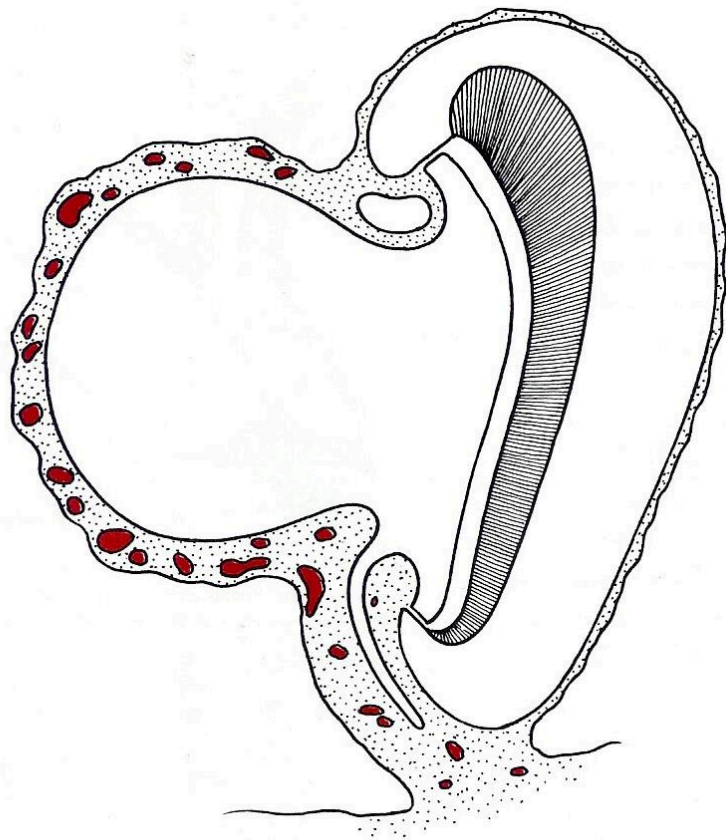


Fig. 1.— Schéma d'un embryon humain de 3 semaines.

ABB. — *Menschlicher Embryo 3 Wochen*